

LA PAROI ABDOMINALE

I-INTRODUCTION

La paroi abdominale est l'ensemble des parties molles permettant, le maintien des organes abdominaux en place. Elle est constituée de deux parties :

- Une partie antéro-latérale : musculo-aponévrotique, est en rapport directe avec les viscères digestifs.
- Une partie postérieure : ostéo-musculaire, répondant essentiellement à l'appareil urinaire, et aux gros vaisseaux.

II-LA PAROI ABDOMINALE ANTERO-LATERALE

La paroi abdominale antéro-latérale circonscrit la plus grande partie de la cavité abdominale en formant une vaste sangle constituée d'éléments musculo-aponévrotique souples et déformables.

A-REPERES

a-Repères osseux

En crânial : Le processus xiphoïde, au milieu et le rebord costal, latéralement.

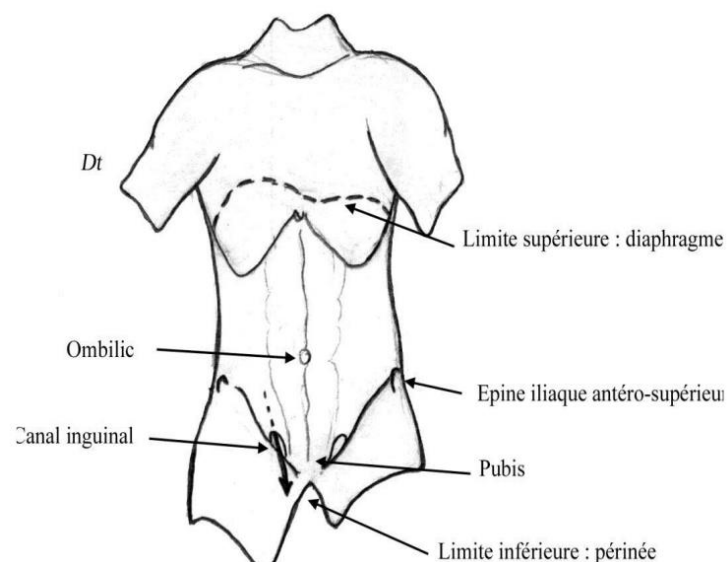
En caudal : En latéral, l'épine iliaque antéro-supérieure et la crête iliaque et en médial, l'épine du pubis.

b-Repères Musculaires

Bord latéral des muscles droits, surtout visibles chez le sujet musclé.

c-Repères Cutanés

Sillon médial ventral (ligne blanche), ombilic (nombril), pli ou sillon inguinal.



Repères de la paroi abdominal

B-DIVISIONS TOPOGRAPHIQUES

À partir de ces repères, on décrit les différents quadrants de l'abdomen, on divise la paroi abdominale par 4 lignes en 9 quadrants.

- Deux lignes horizontales, l'une supérieure passant par le rebord costal et l'autre inférieure passant par les épine iliaques antéro-supérieures.

- Deux lignes verticales passant au niveau du bord latéral des muscles droits.

Ainsi ces lignes permettent de délimiter 9 quadrants :

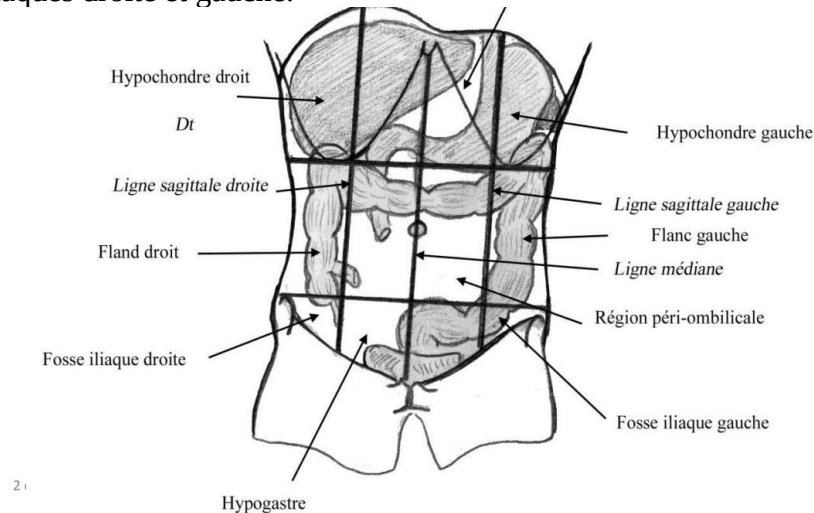
Au milieu de la paroi, de haut en bas :

La paroi abdominale. Pr Benleghib N.

- La région épigastrique
- la région ombilicale
- la région hypogastrique

Latéralement, de haut en bas :

- les hypochondres droit et gauche
- les flancs droit et gauche
- les fosses iliaques droite et gauche.



Divisions topographiques de l'abdomen

C-CONSTITUTION

Elle est constituée, de chaque côté de la ligne médiane xipho-pubienne, par :

- latéralement, les muscles larges de l'abdomen
- en ventral, les muscles droits de l'abdomen
- en caudal, les muscles pyramidaux

a-Les muscles larges

On retrouve 3 muscles pairs et plats, de la superficie à la profondeur :

- Le muscle oblique externe
- Le muscle oblique interne
- Le muscle transverse

1-Le muscle oblique externe

Le plus superficiel

Origine : face externe des 7 dernières côtes.

Trajet : oblique en caudal et médial

Terminaison :

Partie supérieure : sur la crête iliaque.

Partie antérieure : Participe à former la gaine du muscle droit de l'abdomen.

Partie inférieure : forme deux piliers, latéral sur le ligament inguinal et médial sur le pubis.

2-Le muscle oblique interne

Origine : essentiellement sur la crête iliaque et le ligament inguinal.

Trajet : oblique en crânial et médial.

Terminaison :

Partie supérieure : face externe des côtes (10- 12^e côtes) et 10^eme cartilage costal.

Partie antérieure : Participe à former la gaine du muscle droit de l'abdomen.

Partie inférieure : s'unit avec celle du transverse pour former le tendon conjoint.

3-Le muscle transverse

Le plus profond

La paroi abdominale. Pr Benleghib N.

Origine :

- Face interne des 6 dernières côtes.
- processus transverses des 4 premières lombaires.
- crête iliaque.

Trajet : transversal en écharpe ou en ceinture

Terminaison :

- Participe à former la gaine du muscle droit de l'abdomen.
- en bas il s'unit avec celle de l'oblique interne pour former le tendon conjoint.

b- Le muscle droit de l'abdomen

C'est un muscle vertical, pair, situé de chaque côté de la ligne médiane et entrecoupé de 3 ou 4 intersections tendineuses, dans sa portion sus ombilicale.

Origine :

- 5-6ème côte
- 6 et 7èmes cartilages costaux
- processus xiphoïde

Trajet : vertical

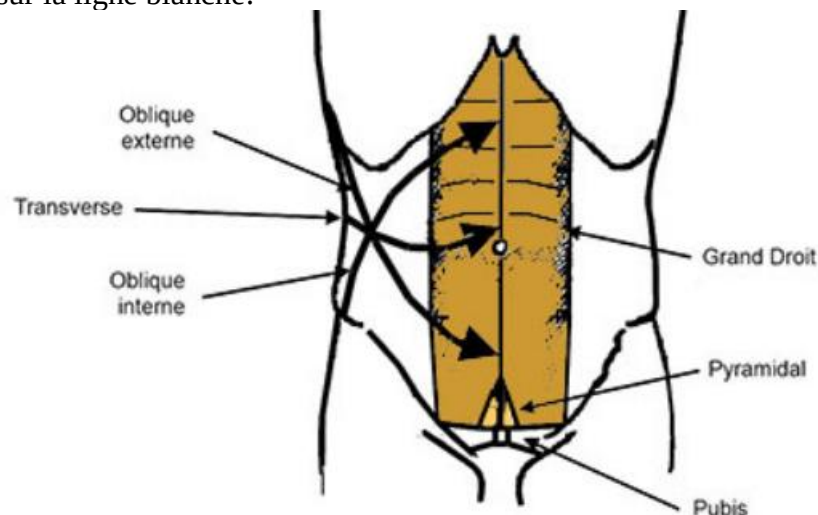
Terminaison : par un tendon sur le pubis.

c-Le muscle pyramidal

Petit muscle, inconstant, pair, annexé à la face ventrale du muscle grand droit.

De forme triangulaire, à base inférieure, situé de part et d'autre de la symphyse pubienne.

Il se termine sur la ligne blanche.



Les muscles de l'abdomen

d-La gaine du muscle droit de l'abdomen

Elle est formée par la réunion des aponévroses des muscles larges. Chaque muscle comporte un feuillet aponévrotique ventral et un feuillet aponévrotique dorsal.

En sus-ombilical

- Oblique externe : les 2 feuillets, ventral et dorsal, passe en avant des muscles grands droits
- Transverse : les 2 feuillets, ventral et dorsal, passe en arrière des muscles grands droits
- Oblique interne : le feuillet ventral passe en avant des muscles grands droits, le feuillet dorsal passe en arrière des muscles grands droits.

En sous-ombilical :

Les feuillets aponévrotiques dorsaux et ventraux des 3 muscles larges passent tous en avant des muscles grands droits.

La face ventrale de la paroi ventro-latérale est recouverte par le fascia superficialis, le tissu graisseux sous-cutané et la peau.

La paroi abdominale. Pr Benleghib N.

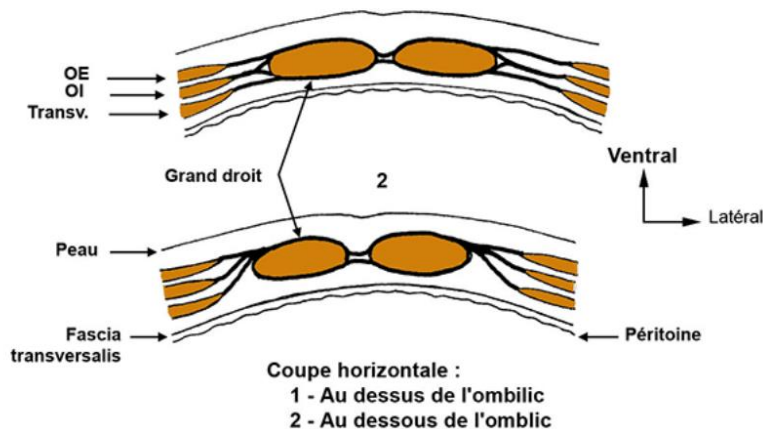
La face dorsale de la paroi ventro-latérale est tapissée par le fascia transversalis recouvert à son tour par le péritoine.

e-La ligne blanche

-Située sur la ligne médiane, sépare les 2 muscles droits, depuis le processus xiphoïde jusqu'au pubis, interrompue par l'ombilic.

-Est donc formée par la réunion des aponévroses des muscles larges.

-C'est très souvent la zone des laparotomies, dites médianes.



D-LES POINTS FAIBLES DE LA PAROI VENTRO-LATÉRALE

a- Ombilic :

C'est le vestige (reliquat) du cordon ombilical. Est un anneau fibreux retractoré de 10 à 15 mm de diamètre adhérent à la peau et au péritoine, se situe sur la ligne blanche, un peu au-dessous de son milieu.

b-Le canal inguinal :

Le canal inguinal est un canal livrant passage :

-au cordon spermatique chez l'homme et

-au ligament rond de l'utérus chez la femme.

On lui décrit classiquement 4 parois et deux orifices :

-**paroi inférieure** : ligament inguinal.

-**paroi supérieure** : la partie charnue du muscle oblique interne et du muscle transverse.

-**paroi ventrale** : Peau, fascia abdominal superficiel, aponévrose du muscle oblique interne.

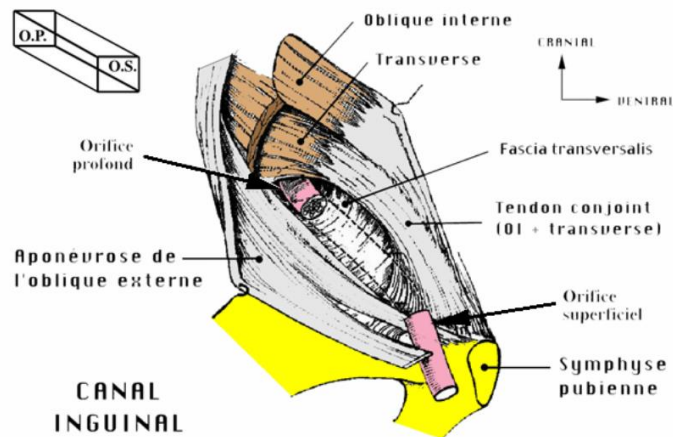
-**paroi dorsale** : fascia transversalis en dehors et le tendon conjoint en dedans.

-**deux orifices** :

-L'un superficiel, ventral, délimité par les deux piliers du muscle oblique externe.

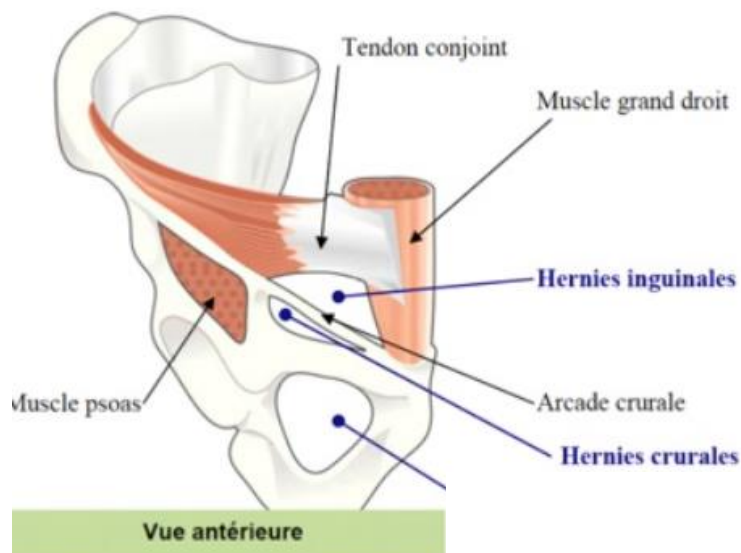
-L'autre profond, dorsal, délimité par le tendon conjoint et le ligament inguinal.

La paroi abdominale. Pr Benleghib N.



c-Le canal fémoral

Est situé au-dessous du canal inguinal dont il est séparé par le ligament inguinal. Au cours d'une augmentation trop importante de la paroi intra abdominale, le canal fémoral laisse passage à des hernies appelées hernies fémorales ou crurales.



III-PAROI LOMBALE ou DORSALE

Elle est située à la face dorsale de l'abdomen, limitée de chaque côté :

- en médial, par les processus épineux des vertèbres lombales (ou lombaires), nettement perceptibles sous la peau.
- en latéral, elles se poursuivent par la paroi abdominale ventro-latérale.
- en crânial, la 12^{ème} côte.
- en caudal, la crête iliaque.

A-CONSTITUTION

Comporte trois plans

Plan superficiel : comportant

- la lame postérieure du fascia thoraco-lombaire
- Muscle grand dorsal, muscle oblique externe

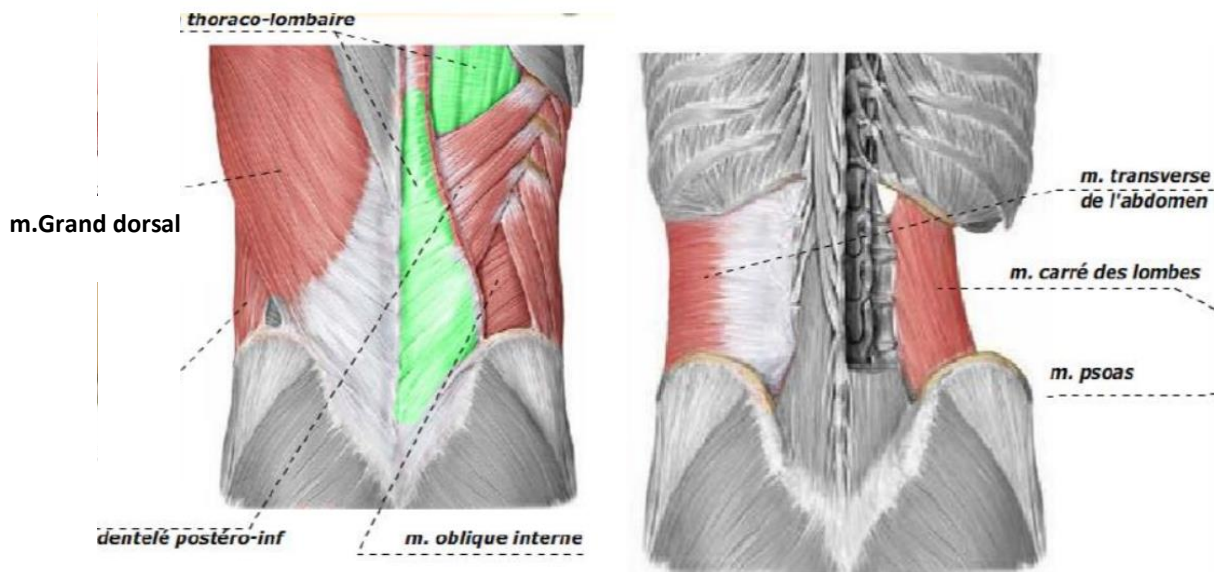
Plan moyen : comportant

- Muscles érecteurs du rachis, muscle oblique interne et muscle dentelé postéro-inferieur.

Plan profond : comporte de la profondeur à la superficie:

La paroi abdominale. Pr Benleghib N.

- Muscle transverse de l'abdomen
- Muscle carré des lombes
- Muscle psoas



PAROI LOMBALE

B-LES POINTS FAIBLES

1-Le trigone lombal, « triangle de Jean-Louis Petit », ou trigone lombaire,

- orifice triangulaire situé dans la région dorsale.
 - délimité crânialement et médialement par le muscle grand dorsal, en haut et en dehors par le muscle oblique externe de l'abdomen et en bas par la crête de l'os iliaque.
- Cet orifice triangulaire constitue un point faible de la paroi postérieure de l'abdomen, mais il est rare qu'il puisse livrer passage à une hernie, car son plancher est musculaire, constitué du muscle oblique interne de l'abdomen.

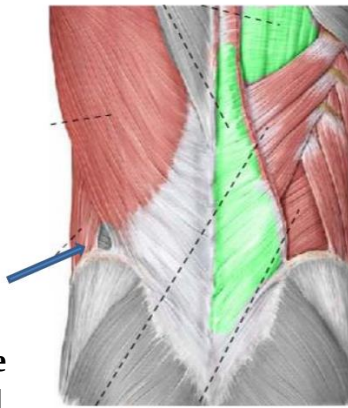
2-Le quadrilatère lombaire de Grynfeldt

Est un orifice à quatre côtés, situé dans la paroi postérieure de l'abdomen. Limité par :

- le muscle oblique interne de l'abdomen en dehors,
- les muscles érecteurs du rachis en dedans et le muscle dentelé postérieur et inférieur en haut.
- La crête iliaque en bas

À travers cet office, on aperçoit le muscle carré des lombes.

**Le
trigone
lombal**



**Le
quadrilatère
lombaire de
Grynfeldt**

